

作者：张思玮 张帆 来源： 中国科学报 发布时间：2025-9-11

选择字号：小 中 大

失眠症诊断治疗有了新指南

■本报记者 张思玮 见习记者 张帆

“失眠症不仅会增加高血压、心力衰竭、冠心病和脑卒中等躯体疾病，以及抑郁症、焦虑症和创伤后应激障碍等精神障碍的患病风险，还可能引发工作失误、工伤、交通事故和死亡等一系列公共卫生问题。”近日，南方医科大学南方医院精神心理科（睡眠医学中心）主任医师张斌向《中国科学报》表示，失眠症不仅影响患者生活质量，也给家庭和社会带来沉重负担。

2023年10月，中国睡眠研究会联合睡眠医学领域专家，成立了指南编写专家委员会，张斌担任组长。近日，由该委员会更新制定的《失眠症诊断和治疗指南（2025版）》（以下简称《指南》）发表于《中华医学杂志》。

据了解，《指南》结合2017年以来的最新研究成果，进一步明确了失眠症的诊断标准，优化了治疗方案，特别制定了针对特殊人群的个性化治疗策略，强调了多学科联合治疗的重要性，以及中医药在失眠症治疗中的应用价值。

明确失眠症诊断流程

睡眠占据了人类生命时间的1/3。一篇回顾50多项流行病学研究的综述曾指出，普通人群中有关失眠症状的为30%至48%。

《指南》优化了失眠症的定义与分类体系。首先，将失眠症定义为“持续的睡眠起始或维持困难，与担忧睡眠、睡眠不满意或日间功能损害有关”；其次，将失眠症分为慢性失眠症、短期失眠症及其他失眠症共3个类别；最后，因失眠症具有高度异质性，《指南》将其分为多个亚型，有助于理解致病机制，发现生物标志物，实现个体化治疗。

张斌特别指出，年龄、性别、失眠症既往史、遗传因素、个性特质、应激及生活事件、精神障碍、躯体疾病等都是失眠症的危险因素。

《指南》给出了标准化诊断流程，包括详细的病史采集，结合量表评估、睡眠日记等主观评估工具，并完成体格检查、实验室检查和精神检查，必要时辅以多导睡眠监测（PSG）等客观检查。

张斌提醒，失眠症还应重点鉴别其他常见睡眠障碍，以及可能引起或加重失眠症的躯体疾病、精神障碍或物质滥用，明确失眠症是独立疾病、共病还是其他疾病的症状表现。

完善失眠症综合治疗策略

关于失眠症的药物治疗，《指南》建议，应在病因治疗、失眠认知行为疗法和睡眠健康教育的基础上酌情使用。

目前，美国食品药品监督管理局批准用于失眠症治疗的药物主要包括苯二氮[■]受体激动剂（BZRA）、食欲素双受体拮抗剂（DORA）、褪黑素受体激动剂（MRA）和多塞平等。此外，临床上会以“被超说明书”方式，将部分抗抑郁药和抗癫痫药用于失眠症治疗。在药物治疗顺序方面，《指南》将短中效BZRA或DORA作为一线药物，其他BZRA或MRA作为二线药物。

《指南》还在失眠症的心理行为治疗方面给出建议，将失眠认知行为疗法（CBTI）作为一线治疗。“除了CBTI，其他的心理治疗方法还包括正念疗法、音乐疗法、催眠疗法、昼夜节律支持、矛盾意向疗法和强化睡眠再训练等，可根据患者的具体特点和需求选择辅助治疗手段。”张斌表示。

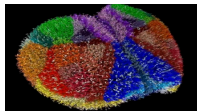
另外，《指南》将光照疗法、生物反馈疗法、芳香疗法、声音疗法等物理治疗视为药物治疗及心理治疗的有效补充，尤其适用于药物不耐受或心理治疗依从性差的患者。同时，在中医治疗方面给出了详细建议。

相关新闻

相关论文

- 1 新研究揭示DNA末端切除全新调控机制
- 2 碳排放大户需为热浪增幅负半数责任
- 3 火星泥岩可能形成于生命宜居条件
- 4 中国学者发现由单基因导致的红斑狼疮
- 5 中山眼科中心签约C9“生命之翼”航空医疗联盟
- 6 广州中医药大学2025年师德建设主题教育月启动
- 7 中山大学发布“逸心”心理健康教育大模型
- 8 基孔肯雅热疫情防控研究获进展

图片新闻



>>更多

一周新闻排行

- 1 关于为2025年度“双十”活动推荐候选新闻的启事
- 2 中国科学院2025年院士增选结果公布
- 3 中国工程院2025年院士增选结果公布
- 4 全新研究方向无创透皮给药解决患者“怕打针”难题
- 5 “博导”郭伟的双面人生：村里不确定其是否上过大学
- 6 澄清了！NASA公布3I/ATLAS最新图像
- 7 从盲目拼图到智能复原：AI照亮生命的未知版图
- 8 即将开始准备基金本子？这点需要尽早注意！
- 9 无需注射！新型聚合物可透皮输送胰岛素
- 10 大脑感知母语和外语具有跨语言共性

编辑部推荐博文

- 即将开始准备基金本子？这点需要尽早注意！
- 科学网2025年10月十佳博文榜单公布！
- 不会选刊？少点灵感？收藏Taylor&Francis这些好用的工具与资源！
- 白鹭归来
- AMR Account | 聚噁二唑：从“高温战士”到“能源多面手”的逆袭之路
- 下一代智能体的关键：“它主”机制

更多>>

张斌表示，失眠症应以采用综合治疗方式，积极查找病因及共病、判断治疗优先顺序、优先选用CBTI为原则。CBTI联合药物治疗是常用的综合治疗方案，病情稳定后可改为间断用药模式。

特殊人群个性化治疗

《指南》针对特殊人群的失眠症，如儿童青少年、女性、老年人等，给出了个性化治疗方案。

根据流行病学统计，青少年失眠症的患病率为3%至39%，在16至18岁青少年中，男性为12%、女性为23%。《指南》认为，对于儿童青少年失眠症，首选行为治疗，药物治疗仅在行为治疗无效且睡眠问题严重时谨慎使用，需遵循最短疗程、最低剂量原则，并由专业医师严密监测。

数据显示，青春前期失眠症在男女性中的发病率无显著差异，青春后期女性失眠症发病率为男性的1.5至2.0倍。“女性失眠症具有明显的年龄和生理周期特点，月经初期、黄体期晚期、妊娠期和（围）绝经期是女性失眠症的高发阶段。”张斌表示。

《指南》建议，对于妊娠、哺乳期成年女性，首选非药物治疗，特别是CBTI，如需药物治疗，需遵循联合非药物治疗、短程、单药、安全优先的原则。对于（围）绝经期成年女性，《指南》建议制定个体化方案，重点关注睡眠卫生习惯。

此外，数据还显示，超过50%的老年人报告有睡眠障碍，其中20%至40%的老年人报告有失眠症。《指南》建议，老年失眠症患者治疗首选非药物疗法，特别是CBTI。老年人药物治疗应遵循尽量减少服药种类、小剂量起始、缩短用药时间的原则，避免长效镇静催眠药物，密切监测不良反应，警惕跌倒风险，并注意药物相互作用。

相关论文信息:

<http://doi.org/10.3760/cma.j.cn112137-20250421-00981>

《中国科学报》（2025-09-11 第3版 综合）

打印 发E-mail给: go